Evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje oral

Unidad 2. Clasificación, descripción y etiología de las alteraciones del habla y la voz (I)

UNIDAD 2

Unidad 2. Clasificación, descripción y etiología de las alteraciones del habla y la voz (I)

ÍNDICE

1. Introducción.....2

2. Alteraciones del lenguaje oral: hacia una delimitación de parámetros diferenciadores 2

3. Clasificación de las alteraciones del lenguaje oral 3

3.1. Introducción a las clasificaciones 3

3.2. Alteraciones del habla y la voz primarias.....6

3.2.1. Introducción 6

3.2.2. Retraso evolutivo del habla o RSH 7

3.2.2.1. Conceptualización, características y desarrollo de la alteración 7

3.2.2.2. Complejidad etiológica.....8

3.2.3. Trastorno de los Sonidos del Habla o TSH.....11

3.2.3.1. Conceptualización, características y desarrollo de la alteración 11

3.2.3.2. Radiografía de las alteraciones fonético-fonológicas 13

3.2.3.3. Sintomatología y etiología.....13

3.2.3.4. Taxonomía del TSH: criterios para establecer el nivel de severidad de la alteración 15

3.2.3.5. Evaluación 16

3.2.3.6. Intervención 17

3.2.3.7. Una última actualización en el Trastorno de los Sonidos del Habla: ¿por qué es un problema a tener en cuenta en el ámbito educativo?.....21

BIBLIOGRAFÍA.....23

1. Introducción

Las alteraciones del habla y la voz son alteraciones, muchas veces coexistentes, que pueden afectar a la articulación, la fonología, la voz y/o la fluencia, aunque también pueden deberse a causas desconocidas, es decir, estar asociadas con obstáculos en la estructura o función de la boca, cara o paladar, pérdida de audición, alteraciones de las cuerdas vocales o a la frecuencia respiratoria, desequilibrio en los sonidos producidos, o incluso relacionarse con una respuesta al estrés ambiental (Coll-Florit et al., 2014).

En relación con ello, cualquier clasificación de los factores patológicos del habla y la voz, y, con ellas, del lenguaje tiene una cuota de arbitrariedad y, por eso, son numerosas las taxonomías que se han establecido a lo largo de la literatura clínica, logopédica y educativa (Cepeda, 2019).

Teniendo en cuenta lo anterior en esta unidad tiene como objetivos: (I) trabajar con la clasificación general de las alteraciones del lenguaje oral y sus implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje; (II) visualizar la panorámica de todas las alteraciones del lenguaje oral existentes para, posteriormente, hacer especial hincapié, en las alteraciones del habla y la voz y, por último, (III) conocer la evaluación e intervención de los diversos trastornos del habla y la voz para, como especialistas, poderlos aplicar, teniendo en cuenta sus implicaciones, en el ámbito de la enseñanza.

2. Alteraciones del lenguaje oral: hacia una delimitación de parámetros diferenciadores

Generalmente, las alteraciones del lenguaje oral implican dificultades en la adquisición de este campo tanto a nivel de comprensión como de expresión, existiendo así un desfase entre el lenguaje oral del niño y su edad cronológica.

Estas obstaculizaciones pueden variar desde simples substituciones de sonido hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje o mecanismo motor-oral para el habla y alimentación.

En lo que respecta a su etiología general, esta es multifocal, es decir, algunas causas de las alteraciones del lenguaje oral incluyen la pérdida auditiva, trastornos neurológicos, lesión cerebral, discapacidad intelectual o impedimentos tales como labio leporino y abuso o mal uso vocal, entre otros. Sin embargo, con mucha frecuencia se desconoce.

Finalmente, entre las numerosas tipologías existentes la más utilizada es la que divide las alteraciones del lenguaje oral en tres vertientes: *habla y voz*; *fluidez* y *desarrollo del lenguaje*.

3. Clasificación de las alteraciones del lenguaje oral

3.1. Introducción a las clasificaciones

El campo de las alteraciones del lenguaje oral es muy amplio. Ha recibido a lo largo de la historia y según diversas escuelas, diferentes enfoques y por lo tanto distintas caracterizaciones. Destacando, siempre, en el campo clínico, por encima de todas ellas, tres: DSM, ASHA y Narbona y Chevrie-Muller (véase Tabla 1).

En lo que respecta al campo educativo, actualmente las alteraciones del lenguaje oral se rigen por la clasificación de Susanibar et al., (2016), la cual se expondrá más adelante. Sin embargo, también se tiene muy en cuenta la ofrecida por la nueva ley educativa, la LOMLOE quien las incluye dentro del campo de las ACNEAE: *Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.*

- Necesidades educativas especiales (discapacidad física, psíquica o sensorial, TEA o TGC)
- Retraso madurativo.
- **Trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación.**
- Trastorno de atención o aprendizaje.
- Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje
- Situación de vulnerabilidad socioeducativa.
- Altas capacidades.
- Incorporación tardía, Condiciones personales o historia escolar.

Desaparecen las dificultades de aprendizaje y los alumnos TDAH.

Tabla 1.

Criterios de clasificación de los trastornos del lenguaje oral

Criterios de clasificación	¿Qué plantean?	Diferencias	Semejanzas	Categorías diagnósticas
DSM-5-TR	El DSM-5-TR (2022) recae en el origen neurobiológico de los trastornos del lenguaje y pertenece a la Asociación de Psiquiatría. Cabe destacar que está conformado por distintos bloques y en el primero se encuentran los trastornos del neurodesarrollo, estos mismos son planteados como la causa de las deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional.	1. La categoría de trastornos del lenguaje se centra en las dificultades persistentes para la adquisición y uso del lenguaje ocasionadas por problemas en la comprensión y expresión del lenguaje. 2. Los criterios del DSM-5-TR son los únicos que plantean y se expanden en el trastorno del espectro del autismo, aunque en una clasificación aparte de los trastornos de la comunicación.	1. El DSM-5-TR y los criterios realizados por Narbona y Chevrie-Muller incluyen al tartamudeo en sus criterios. 2. El DSM-5-TR y el ASHA plantean que los trastornos del lenguaje se dan en parte por deficiencias en el desarrollo del niño.	Trastorno del lenguaje (incluidos el TEL y la disfagia). Trastorno fonológico Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia (tartamudeo) Trastorno de la comunicación social (pragmático) Trastorno de la comunicación no especificado
ASHA	La Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición (ASHA) plantea que los trastornos de la comunicación son agrupados en solo tres categorías con sus definiciones y variaciones. ASHA estima que entre el 15% y el 25% de los niños pequeños padecen algún tipo de trastorno de la	1. La categoría de trastornos del lenguaje se centra en los problemas del desarrollo general y/o en el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL), término que ASHA adoptó siguiendo el consenso internacional CATALISE (Bishop et al., 2017). 2. ASHA especifica que los trastornos	1. Los criterios del ASHA y los criterios de Narbona y Chevrie-Muller toman en cuenta los trastornos de la audición. 2. El ASHA y el DSM-5-TR plantean a la mala articulación de los fonemas como causa de un	Trastornos del lenguaje Trastornos del habla Trastornos de audición

	comunicación.	de la audición se concentran principalmente en trastornos de la comunicación que no son el resultado de una pérdida auditiva, mientras que Narbona y Chevrie- Muller plantean que sí lo son y hasta los clasifican.	trastorno, ASHA lo plantea en su categoría de los trastornos del habla y el DSM-V-TR en su categoría de los trastornos fonológicos.	
Chevrie-Muller y Narbona	Ambos autores plantean la actividad lingüística como resultado de la unión y funcionamiento de los aspectos cognitivo y cerebral. Las categorías son ubicadas en un cuadro de doble entrada, en las columnas se ubica el criterio etiológico y en las filas las patologías con sus diferentes características, las cuales conllevaran a la evaluación del lenguaje.	1. La categoría de trastornos del lenguaje se centra en las patologías por estados deficitarios y los trastornos de la comunicación, ambos divididos en congénitos y adquiridos. 2. Narbona y Chevrie- Muller atribuyen la tartamudez a las disfluencias, mientras que en el DSM-5-TR se especifica que las disfluencias no son la causa de la tartamudez.	1. Narbona y Chevrie- Muller en su segunda categoría, en el nivel terciario, plantean como patología los déficits lingüísticos los cuales engloban la comprensión y expresión del lenguaje al igual que en el DSM-5-TR en la categoría de trastornos del lenguaje. 2. Narbona y Chevrie- Muller, en su segunda categoría (tercer nivel), incluyen a las patologías del lenguaje escrito, así como lo hace ASHA en los trastornos del lenguaje entre los usos de sistemas.	Déficit en los instrumentos de base. Trastornos neurolingüísticos (gnoso-práxico-lingüísticos) incluye el lenguaje escrito. Tartamudez. Trastornos del lenguaje en psicopatología y carencias del entorno.

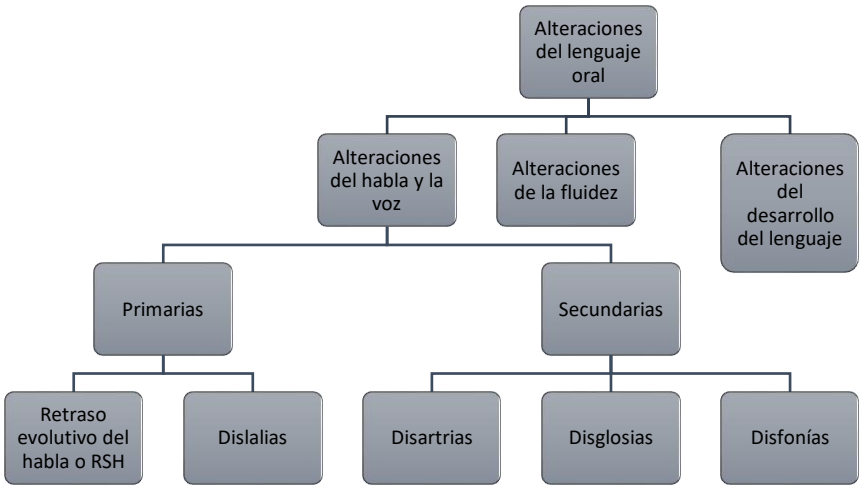
3.2. Alteraciones del habla y la voz primarias

3.2.1. Introducción

Como se expuso en puntos anteriores, una de las clasificaciones más utilizadas dentro del campo de las alteraciones del lenguaje oral es la llevada a cabo por Susanibar et al. (2016), quienes las dividien en tres vertientes principales: habla y voz; fluidez y desarrollo del lenguaje (véase Figura 1).

Figura 1.

Clasificación de las alteraciones del lenguaje oral (Susanibar et al., 2016)



Las **alteraciones del habla** son alteraciones, muchas veces **coexistentes**, que **pueden afectar a la articulación, la fonología, la voz y/o la fluidez**, aunque también pueden deberse a causas desconocidas (Coll-Florit et al. 2014), es decir, estar asociadas con:

- Obstáculos en la estructura o función de la boca, cara o paladar, pérdida de audición.
- Alteraciones de las cuerdas vocales o a la frecuencia respiratoria.
- Desequilibrio en los sonidos producidos.
- Respuesta al estrés ambiental.

Las **características principales** de estas alteraciones son:

- Etiología de carácter múltiple: *afectivo, evolutivo, cultural, traumático, psicológico.*
- Habla espontánea poco inteligible.
- Errores práxicos y *feedback* auditivo deficiente.
- Si la alteración está generalizada, la articulación o el habla se verán gravemente afectados.
- Dificultad para establecer diferenciaciones auditivas precisas.
- Nivel lingüístico máximo afectado: la palabra.

Por su parte, la voz es un sonido que se produce en la laringe, pero cuyos criterios objetivos y absolutos no existen. Sin embargo, sí se debe tener claro que para realizar dicho sonido será preciso conjugar múltiples aspectos psicofisiológicos que determinen su calidad, acústica y su ejecución (Susanibar et al. 2016).

Se considera que hay una alteración de la voz cuando **su timbre, tono, intensidad o flexibilidad difieren de los de las voces de las demás personas del mismo género, edad y grupo cultural con desarrollo típico.** Entre las **causas** de las alteraciones de la voz destacan**:**

- Bronquitis crónica, asma, vegetaciones, laringitis.
- El origen de los problemas de voz puede ser:
- Traumático (accidentes, sustos).
- Ambiental (elevación de la voz en situaciones ruidosas).
- Funcional (pólipos, nódulos en la garganta).
- Orgánico (malformaciones laríngeas).

3.2.2. Retraso evolutivo del habla o RSH

3.2.2.1. Conceptualización, características y desarrollo de la alteración

El RSH lo presenta un sujeto que tiene afectado el sistema fonológico, mientras que sus habilidades fonéticas estarían bien desarrolladas. Sería capaz de articular todos los fonemas por imitación, pero tendría dificultades para integrarlos en palabras y lenguaje espontáneo (Macías, 2010).

Es un desfase significativo en la aparición (comienzo tardío) y en el desarrollo de la expresión oral (evolución lenta) que no puede ser explicado por un retraso mental, que tampoco se debe a un trastorno generalizado del desarrollo, ni a déficit auditivo, o trastornos neurológicos (McCauley y Fey, 2006).

No es un trastorno tanto de la articulación fonética, sino de estructuración fonológica, que está atrasada para su edad cronológica. La comprensión es prácticamente típica para su edad y la actividad no lingüística se encuentra también dentro de la tipicidad (véase Tabla 2).

Tabla 2.

Edades de adquisición fonético-fonológica (Rojas y Susanibar, 2019).

[1]Cuadro de adquisición fonética-fonológica									
Vocales	**2 años**	**<a> = L**	**<o> = NL**	**<u> = NG**	**<e> = D**	**<i>**			
Diptongos	**3 años**	**<ia>= L**	**<io>**	**<ie>**	**<ue>**	**<ua>**	**<ei>**	**<ai>**	**<ui>**
	4 años	**<au>**							
Consonantes	**3 años**	**<m>**	**<n>**	**<ñ>**	**<p>**	**<t>**	**<k>**	**<b>**	**<d>**
		<g>	**<f>**	**<s>**	**<j>**	**<y>**	**<ch>**	**<l>**	
	4 años	**<r> (ISIP)**							
	5 años	**<r> (CSIP y CSFP)**			**<rr>**				
Grupos consonánticos	**4 años**	**<pl>**			**<bl>**				
	5 años	**<fl>**		**<cl>**		**<fl>**			
		** **	**<fr>**	** **	**<fr>**	** **	**<fr>**	** **	
Posición de los sonidos dentro de la palabra	**ISPP**	Inicio Silábico al Principio de la Palabra (Ej.: **n**ada, **l**uz)							
	ISIP	Inicio Silábico en Interior de la Palabra (Ej.: ma**n**o, pa**l**a)							
	CSIP	Coda Silábica en Interior de la Palabra (Ej.: a**n**tes, a**l**ma)							
	CSFP	Coda Silábica al Final de la Palabra (Ej.: leó**n,** sa**l**)							
valores	**L = Logrado**		**NL = No Logrado**		**NG = No Generalizado**		**D = Distorsionado**		

3.2.2.2. Complejidad etiológica

Como se ha mencionado, el RSH es una alteración en la organización fonológica del lenguaje (que puede afectar seriamente a su expresión). Son capaces de pronunciar sonidos aislados y grupos de sonidos, pero a la hora de su ordenación y diferenciación dentro de las palabras presentan dificultades (Coll-Florit et al., 2014). Quienes la presentan tienen:

- Nivel de comprensión *típico*.
- El desarrollo semántico y morfosintáctico, aunque no apartándose de patrones normalizados, pueden estar ligeramente retrasados.
- La intencionalidad comunicativa puede verse inhibida, en función de sus experiencias personales y respuestas de contexto social, familiar, etc...
- Son niños y niñas que evolucionan favorablemente, dependiendo de los contextos en los que se desenvuelven y con una adecuada intervención logopédica.

Entre los factores de gravedad de menor a mayor, siguiendo a Billard (2014), se pueden concretar:

- Errores dentro del mismo campo fonológico: punto de articulación.
- Errores fuera de ese campo fonológico: modo de articulación.
- Sustituciones: sordo/sonoro.

- Desfases en la madurez personal y neurobiológica.
- Déficit en la percepción fonológica y memoria auditiva.
- Dificultades para establecer y organizar un sistema fonológico estable.

El niño es capaz de articular todos los sonidos, el problema es que en lenguaje espontáneo no es capaz de "encontrar" el sonido y diferenciarlo de otro. Será capaz de imitar el sonido, ya que la articulación no está afectada, pero pero sí cometerá errores de simplificación fonológica (véase Figura 2).

Figura 2.

Procesos de simplificación fonológica (Susanibar et al., 2016).

PROCESOS RELATIVOS A LA ESTRCUTURA DE LA SÍLABA.

Tienen a simplificar la estructura silábica a la forma básica de CV. Son comunes hacia los 2 años y medio, ya que los niños convierten las palabras en bisílabas o monosílabas utilizando estos tipos de reducción.

a. Omisión de consonantes finales.
   /lapi/ por lápiz.
b. Omisión de consonantes iniciales.
   /fono/ por teléfono.
c. Omisión de consonantes medias.
   /aíta/ por abuelita.
d. Supresión de sílabas átonas.
   /camelo/ por caramelo.
   /pota/ por pelota.
e. Omisión de diptongos.
   /kamó/ por camión.
   /pene/ por peine.
f. Reduplicación - Onomatopeyas.
   /bom-bom/ por tambor.
   /pipa/ por tripa.
g. Reducción de grupos consonánticos. Elimina una consonante de grupos silábicos con varias.
   /pisa/ por prisa.
   /ete/ por este.
h. Epéntesis. Inserción de un fonema vocálico para recuperar la estructura básica.
   /tarator/ por tractor.
i. Metátesis. Inversión de la secuencia de producción silábica.
   /mágala/ por Malaga.
   /crocodilo/ por cocodrilo.
j. Coalescencia. Asimilación de fonemas diferentes que dan lugar a uno nuevo.
   /cuaro/ por cuadro.
   /pierra/ por piedra.

PROCESOS DE SUSTITUCIÓN.

Cambian un sonido por otro, cuando ambos no están próximos en la palabra. Pueden agruparse y clasificarse según el tipo de consonante afectada.

Oclusivas.

a. Posteriorización. Velares y palatales por alveolares o dentales. Las sustituciones de /k/ y /g/ por /t/ y /d/ son muy frecuentes.
   /tasa/ por casa.
   /taeza/ por cabeza.
b. Frontalización. Consonantes anteriores por velares. Es menos frecuente.
   /gez/ por diez.
   /borro/ por gorro.
c. Desonorización.
   /teto/ por dedo.
   /bufanta/ por bufanda.
d. Nasalización. Nasales por oclusivas.
   /meso/ por beso.
   /tambon/ por tambor.
e. Fricativización. Fricativas por oclusivas. Normalmente se da sin cambiar el punto articulatorio.
   /shorro/ por gorro.
f. Labialización. Labiales por dentales.
   /buele/ por duele.
   /papoco/ por tampoco.

Fricativas.

a. Ceceo. /z/ por /s/. Seseo. /s/ por /z/.
   /zopa/ por sopa.
b. Aspiración de la /s/ anterior a una oclusiva.
   /pehte/ por peste.
c. Sonorización. Fricativas sordas por sonoras.
   /vuego/ por fuego.
d. Palatización.
e. Oclusivizacion.

Consonantes Líquidas.

a. Posteriorización. Vibración uvular.
   /grojo/ por rojo.
b. Sustitución por /d/. Ausencia de vibrantes.
   /doto/ por roto. /hadina/ por harina.
c. Conversión. Liquida por fonema /d/.
   /espara/ por espada.
d. Lateralización. O sustitución de líquidas vibrantes simples y múltiples por /l/.
   /latita/ por ratita.
e. Ausencia de lateralización. /l/ por /d/ o /r/.
   /dibro/ por libro.

En /sasa/ por *casa*, hay *asimilación* de /k/ por /s/. Si fuese por un fonema que no está, sería una *sustitución*.

PROCESOS DE ASIMILACIÓN.

Simplifican una palabra, produciendo sonidos diferente de la misma manera. Puede ser:

a. Contigua. Cuando ambos elementos están uno al lado de otro.
b. Distante. Cuando, en la misma palabra, los sonidos que se asimilan están alejados entre sí.

Además, puede ser

a. Progresiva. El elemento asimilado precede al asimilador.
   /liblo/ por libro.
b. Regresiva. El elemento asimilado sucede al asimilador.
   /tristal/ por cristal.

Pueden estar acompañadas de sustituciones o reduplicaciones.

a. Sonorización. Cuando la consonante está antes de una vocal.
   /bato/ por pato.
b. Posteriorización. Consonantes anteriores se asimilan por las posteriores.
   /kaka/ por vaca.
c. Nasalización. Con fonemas orales.
   /mame/ por dame.

Será capaz de repetir /ta/ pero cuando dice la palabra "tapa" el niño/a dirá /'papa/.

Estos errores de simplificación del habla son normales cuando los niños están comenzando hablar, sin embargo a medida que el sistema fonológico va desarrollándose, estos errores deben ir desapareciendo (Cepeda, 2019).

3.2.3. Trastorno de los Sonidos del Habla o TSH

3.2.3.1. Conceptualización, características y desarrollo de la alteración

A lo largo del tiempo, la nomenclatura utilizada para denominar a los sujetos con Trastornos de los Sonidos del Habla, en adelante TSH, fue cambiando según las influencias autorales del momento y las áreas a las que pertenecían dichos investigadores (i.e., medicina, psicología o lingüística). Así, uno de los primeros términos utilizados fue "dislalia", acuñado por el colegio de logopedas de Europa en 1959. Ese mismo año Powers, en EE.UU, utilizó la denominación "trastorno funcional de la articulación" (Martínez-Sánchez, 2010).

Así, ambos términos hacían referencia a alteraciones en la producción de los sonidos, desde la perspectiva articulatoria, describiendo los errores como sustituciones, omisiones, distorsiones y adiciones (SODA). El término "dislalia" se mantuvo en auge hasta alrededor de 1970 en muchos países de Europa, ocurriendo lo mismo en EE.UU con "trastorno funcional de la articulación" (Berthier et al., 2011). En este sentido, cabe mencionar que, en algunos países europeos y latinoamericanos, todavía sigue vigente el término "dislalia".

Siguiendo a Susanibar et al. (2016), en 1975 y 1976, los trabajos de Grunwell e Ingram abrieron el camino terminológicamente para visualizar que la producción de los sonidos del habla involucraba también una organización y representación lingüístico-cognitiva de estos (fonología), lo cual facilitó la comprensión de muchas alteraciones que no estaban siendo explicadas mediante la teoría articulatoria. A partir de este momento, se fueron adoptando diferentes nomenclaturas para referirse a los sujetos con alteraciones en el habla (véase Tabla 1) hasta llegar, actualmente, al término TSH o Speech Sound Disorders (SSD), como se le denomina en la literatura inglesa actual.

Tabla 3.

Terminología utilizada desde 1920 para denominar a los TSH (Bowen, 2015)

Año	Término utilizado
1920-1970	• *Dislalia* en Europa y más tarde *trastorno funcional de la articulación o el habla* en Estados Unidos. • *Articulación* fue el término que englobaba todo.

1971-1980	• *Trastorno de la articulación* y *trastorno fonológico* se utilizó de manera confusa y casi como sinónimos, tanto en la literatura como en la ciencia clínica. • No existía preferencia por ningún término. • La fonología impactó en la evaluación y descripción de errores. Los sujetos presentaban alteraciones articulatorias, fonéticas y fonológicas, pero la intervención era articulatoria.
1981-1990	• Se utilizó el término *articulatorio-fonológico.* Se identificaba a los sujetos con alteraciones fonológicas o articulatorias. • Se daba más énfasis a la fonología, pero con frecuencia se observaba una superposición entre ambos.
1991-2005	• Se prefirió el término *trastorno fonológico*, el mismo que englobaba tanto las alteraciones fonéticas como fonológicas. • Se incorporó también el término *retraso fonológico* o *desarrollo atípico /desordenado* que incluía niveles fonético, fonológicos y reglas fonotácticas.
2005 en adelante	• SSD es el término preferido en la literatura inglesa, lo que traducido al español sería TSH. TSH engloba las alteraciones fonéticas de origen morfológico, neurogénico y/o aprendizaje motor, y fonológicas de origen perceptivo u organizacional. • Sin embargo, en la literatura en español aun persisten términos como *dificultades articulatorias*, *dislalia*, *dificultades fonológicas*, *trastorno fonológico*, entre otros.

De este modo, se define el TSH como una alteración en las producciones articulatorias de los sonidos (fonética) y/o en el uso funcional de los segmentos contrastivos, denominados "fonemas", de un idioma (fonología) que afecta a la inteligibilidad del habla en diferentes grados y puede ser diagnosticada en las distintas etapas de la vida (López et al. 2016).

Tal y como apuntan Susanibar et al. (2016), este planteamiento o definición actual pretende coadyuvar en la solución del debate terminológico suscitado a lo largo de la historia, y ya esbozado en la Tabla 1, permitiendo la uniformidad de la nomenclatura entre investigadores, docentes y clínicos.

Sin embargo, todavía queda pendiente el tema de la precisión de los criterios que deberían ser tenidos en cuenta para que una alteración sea incluida dentro de esta categoría diagnóstica, ya que en algunos casos se utilizan criterios sintomatológicos y etiológicos y en otros solo uno de

estos grupos, lo cual también repercute en que no se hayan establecido con claridad las subclasificaciones de dicha alteración.

3.2.3.2. Radiografía de las alteraciones fonético-fonológicas

La definición del TSH tiene una importancia significativa, ya que lo que se busca es adecuar lo más que se pueda la emisión de los sonidos del habla a los estándares socialmente aceptables, de tal manera que la persona mantenga una comunicación eficiente (Marchesan, 2015).

En este sentido, para la intervención (véase Figura 2) es más relevante identificar y describir la sintomatología y no la etiología, es decir, establecer el perfil de las alteraciones fonéticas y/o fonológicas del sujeto, pues esto permitirá plantear las técnicas e instrumentos que han de ser utilizados durante el tratamiento. Sin embargo, esta postura no excluye la necesidad e importancia de que se busque conocer e identificar la etiología de la alteración (Chávez, 2015).

Figura 3.

Definición para intervención de TSH (Susanibar et al. 2016)



3.2.3.3. Sintomatología y etiología

En lo que concierne a la sintomatología, puede ser de orden fonético, fonológico o ambos. El primero de ellos indica alteraciones consistentes en la incapacidad de producir o articular correctamente los sonidos esperados a una determinada edad cronológica (Coll-Florit et al. 2014). Esta imposibilidad se detecta desde la emisión aislada del sonido como también en sílabas, palabras o, incluso, en una conversación. Los errores son identificados como distorsiones, sustituciones u omisiones y, generalmente, se asocian a dificultades morfológicas

o estructurales, neuromotoras, al uso de prótesis mal adaptadas o incluso al incorrecto aprendizaje motor (Bowen, 2015).

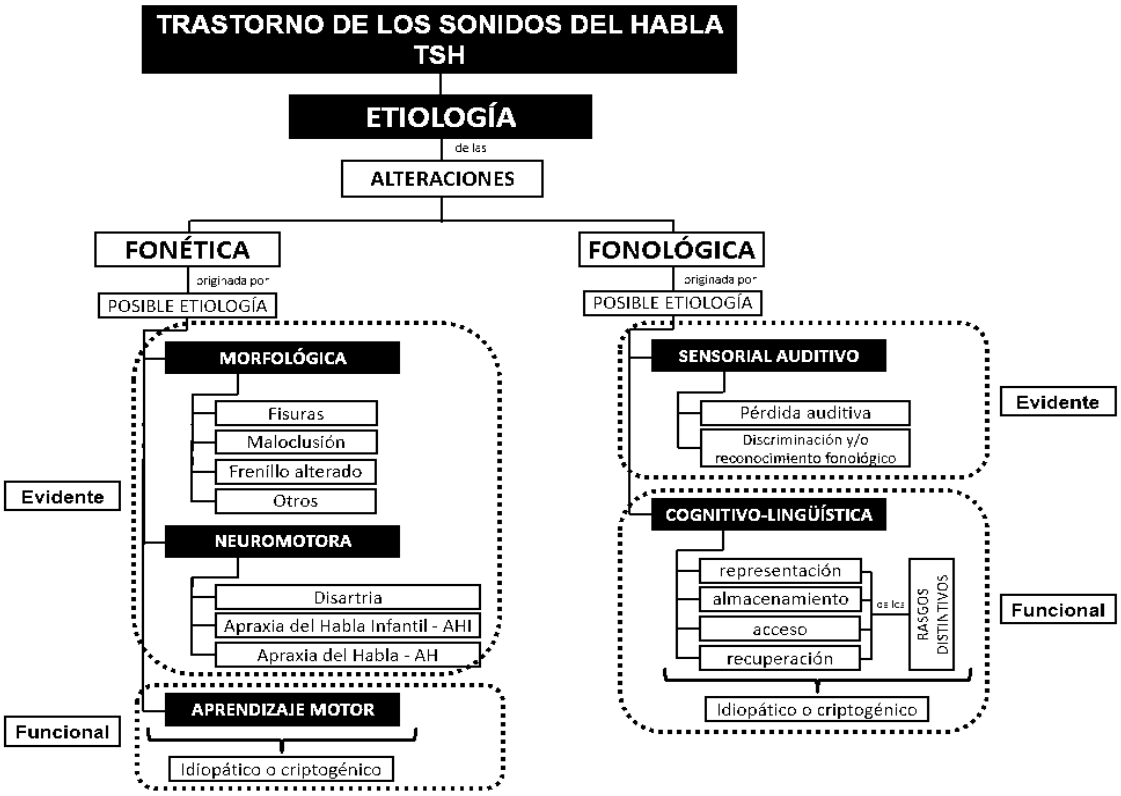
El segundo, por su parte, implica alteraciones consistentes en el uso inadecuado de los segmentos contrastivos esperados para una determinada alteración cronológica (Berthier et al. 2011). Se caracterizan porque el sujeto logra articular de manera aislada o en sílabas el segmento, pero no lo utiliza durante la interacción verbal espontánea, es decir, es capaz de producir un segmento como "p" o la sílaba "pa" e incluso palabras o frases cuando son silabeadas, ya sea con o sin modelos, pero en el habla espontánea puede decir *telota por pelota o *maache por mapache. Así, dichos errores son identificados o denominados como "errores de simplificación fonológica" o "PSF" inusuales que generalmente se asocian a una alteración cognitivo-lingüística o sensorial auditiva (discriminación o reconocimiento fonológico).

Finalmente, el último, tal y como exponen Susanibar et al. (2016), indica alteraciones en las que coexisten errores fonéticos y fonológicos, aunque el número de signos, gravedad, intensidad e inicio de estos varíe de sujeto a sujeto, pudiendo suceder que haya un solo error fonético y varios fonológicos o viceversa, es decir, que se presenten simultáneamente. Sin embargo, también puede suceder que exista una incapacidad para producir correctamente el sonido esperado para su edad cronológica de manera aislada o no y que haya variabilidad en los errores cometidos cuando dicho segmento se encuentra en palabras o habla espontánea (Chávez, 2015).

Por último, en términos de etiología, los TSH se pueden dividir en dos grupos, los que presentan causas conocidas o evidentes y aquellos cuya causa no se conoce, idiopático o criptogenético (véase Figura 4). El primero de ellos incluye aquellos sujetos que evidencian alteraciones morfológicas, neuromotoras, auditivas y cognitivo-lingüísticas que justifican la alteración (Vergara et al. 2020).

Figura 4.

Posibles etiologías del TSH (Susanibar et al., 2016)



Los segundos, por su parte, han sido denominados a lo largo del tiempo como "funcionales", sin embargo, investigaciones recientes, como el de Toledo y De Ávila (2021), indican posibles causas genéticas vinculadas al procesamiento lingüístico (en un 60% de los casos) y/o control motor del habla (10% de los casos) u otitis recurrente dentro del primer año de vida (30% de los casos).

3.2.3.4. Taxonomía del TSH: criterios para establecer el nivel de severidad de la alteración

De este modo, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el profesional deberá tomar en cuenta los criterios anteriormente mencionados, siendo consciente de que lo más conveniente es utilizar de manera óptima los criterios de edad cronológica e inteligibilidad del habla de forma conjunta y tomando en cuenta cuatro niveles de desempeño (véase Tabla 4).

Tabla 4.

Criterios para establecer el nivel de severidad de la alteración FF (Susanibar et al. 2016)

Niveles de	Edad	Inteligibilidad

desempeño		
Alteración adecuada	Emite y utiliza todos los sonidos esperados para su edad cronológica tanto en palabras aisladas a la imitación como en el discurso espontáneo.	Inteligible para cualquier persona.
Alteración leve	Emite y utiliza todos los sonidos correspondientes a edades anteriores, pero falla hasta en dos sonidos esperados a su edad cronológica; o verbaliza los sonidos de edad, pero yerra en un sonido de edades anteriores.	Su habla es inteligible para todas las personas, aunque se requiere un leve esfuerzo para entender lo que quiere decir.
Alteración moderada	Presenta variados errores en los sonidos esperados para su edad cronológica y también en sonidos correspondientes a edades anteriores.	Su habla es inteligible solo para el entorno cercano, las personas ajenas al mismo deben realizar un gran esfuerzo para entenderlo.
Alteración severa	Evidencia múltiples y significativos errores en los sonidos esperados a su edad cronológica y edades anteriores.	Su habla se torna ininteligible, incluso para su entorno cercano.

Fuente: elaboración propia

3.2.3.5. Evaluación

Siguiendo a Rojas y Susanibar (2019), en español existe una heterogénea nómina de instrumentos de evaluación del componente fonético y/o fonológico del lenguaje y, más concretamente, del habla que permiten obtener datos del desempeño para la caracterización integral del sujeto examinado y la posterior formulación de estrategias de intervención individualizadas y de calidad.

Desde el punto de vista de la evaluación educativa, para la evaluación del TSH se puede llevar a cabo una estandarizada o no estandarizada. En relación con la primera, existen los siguientes instrumentos de evaluación:

- PAF. Prueba de articulación de Fonemas (Vallés, 2014). Prueba para evaluar la existencia de Dislalia Funcional en la población infantil comprendida, fundamentalmente, entre los cinco y los ocho años de edad, pero es incluso válida para edades superiores en las que aparezcan alteraciones de articulación. Está constituida por once subpruebas que describen los aspectos intervinientes en el proceso articulatorio.
- RFI (Registro Fonológico Inducido) y PLON-R (Prueba de Lenguaje Oral).
- PEFF. Prueba de evaluación fonético-fonológica. Instrumento diseñado para valorar la producción (fonética) y uso funcional (fonología) de los elementos segmentales y

suprasegmentales del habla. Puede ser administrado a niños a partir de los 2 años y medio a 6-7 años.

Permite al usuario visualizar el desarrollo y aprendizaje normal o deficitario del componente fonético-fonológico del lenguaje. También permite identificar y diferenciar los errores fonéticos y/o fonológicos y brinda una descripción de los tipos de errores y cuál fue su nivel de inteligibilidad del habla.

Además, de examinar detalladamente la fonética y fonología, cuenta con otras subpruebas (anamnesis, percepción fonológica, tasa máxima articulación, acento léxico, entonación) que contribuyen en la identificación de otros síntomas y la posible etiología

Por su parte, en lo que respecta a la evaluación no estandarizada, es necesario recoger y analizar muestras del lenguaje en diversas situaciones (habla espontánea, imitación, e incluso ante la lectura si la ha adquirido), ya que la producción puede variar dependiendo del contexto.

La evaluación de las dificultades articulatorias tendrá como base la del lenguaje espontáneo, y deberá valorarse su inteligibilidad, las dificultades articulatorias y la generalización de los errores en los distintos contextos de su vida. Se recomienda, por tanto, la creación de rúbricas de evaluación que permitan un seguimiento continuo y final.

Dentro de los parámetros de evaluación no estandarizada, se deben tener en cuenta los siguientes:

- Lenguaje espontáneo: detectar distintos tipos de errores y su lugar en la palabra. El especialista de audición y lenguaje hablara con la tutora sobre las actividades que están haciendo en clase y los centros de interés.
- Lenguaje dirigido sin referencia visual: preguntas a contestar con ciertos fonemas. A través del juego “pasapalabra”, se preparan preguntas referentes a cada palabra.
- Lenguaje dirigido con referencia visual: fotos, objetos. Al alumno se le dará un dibujo hecho con figuras geométricas y tendrá que dictar a la especialista el dibujo, por ejemplo: dibuja un cuadrado en el centro del folio.
- Imitación provocada de frases, palabras y sílabas: se hará un teatro o secuencias de teatro imitando escenas de emociones: reír, llorar, sorpresa…diálogos cortos, de una frase o dos y sencillos, que sea capaz de memorizar y en los que se incluyan fonemas en los que presenta error.
- Discriminación auditiva de fonemas.

En definitiva, todo ello permitirá efectuar el análisis del caso y establecer las correspondientes categorizaciones diagnósticas, tanto desde el punto de vista nosológico, como sintomatológico y etiológico (Rojas y Susanibar, 2019; Susanibar et al. 2016).

3.2.3.6. Intervención

La intervención del especialista en audición y lenguaje puede desarrollarse de forma indirecta o directa, en función del destinatario de la actuación y de los objetivos perseguidos. Ambas modalidades son complementarias y contribuyen a favorecer el desarrollo de las competencias comunicativas y lingüísticas del alumnado desde un enfoque preventivo, inclusivo y ajustado a sus necesidades educativas.

a) **Intervención indirecta.** Comprende aquellas actuaciones que el especialista en audición y lenguaje desarrolla sin intervenir de manera directa con el alumnado. Su finalidad es prevenir dificultades en el desarrollo del lenguaje oral, favorecer entornos comunicativos inclusivos y proporcionar orientación y apoyo a los agentes educativos implicados.

Entre las principales actuaciones se encuentran:

- Asesorar al profesorado sobre estrategias metodológicas que favorezcan el desarrollo del lenguaje oral en el aula.
- Orientar a las familias para promover situaciones de comunicación funcionales en el entorno familiar.
- Colaborar en la adaptación de materiales y actividades para facilitar la participación del alumnado.
- Coordinarse con el equipo docente y otros profesionales implicados en la respuesta educativa.
- Diseñar y promover programas preventivos y de estimulación del lenguaje oral en el aula ordinaria.

Cabe mencionar que, tradicionalmente, algunas propuestas de intervención indirecta han incluido ejercicios de praxias orofaciales, mandíbulas, mejillas, velo del paladar, lengua, labios, respiración y soplo. No obstante, estas actuaciones no forman parte de la práctica educativa habitual del especialista en audición y lenguaje, cuya intervención se centra en el desarrollo de las competencias comunicativas y lingüísticas del alumnado en el contexto escolar.

b) **Intervención directa**. Consiste en la atención educativa que el especialista en audición y lenguaje desarrolla directamente con el alumnado, de forma individual o en pequeño grupo, con el objetivo de mejorar sus competencias comunicativas y lingüísticas y favorecer la transferencia de los aprendizajes a los diferentes contextos escolares. Para ello, se diseñan actividades específicas adaptadas a las características del alumnado, entre las que se incluyen:

- Actividades de producción y generalización de los fonemas trabajados en sílabas, palabras, frases y situaciones comunicativas.
- Actividades de discriminación auditiva y producción de pares mínimos.
- Juegos fonológicos y de conciencia fonológica.
- Lectura y producción de rimas, poesías, adivinanzas y trabalenguas.
- Actividades de narración, descripción, conversación guiada y otras tareas comunicativas que favorezcan la transferencia de los aprendizajes al contexto cotidiano.
- Actividades dirigidas a favorecer la generalización de los aprendizajes al aula y a otros contextos de comunicación.

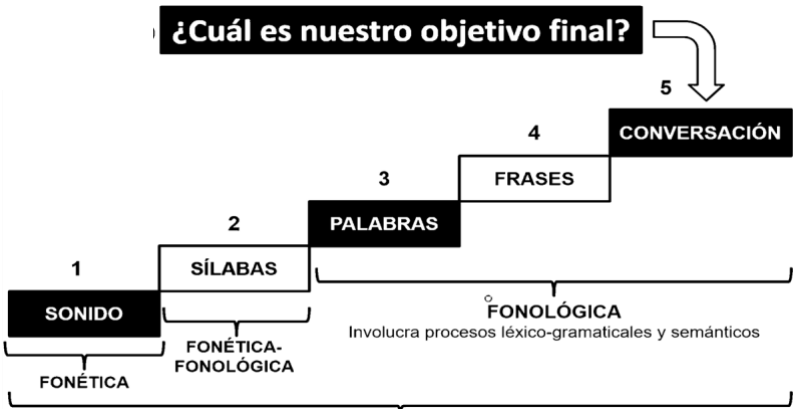
Por su parte, en lo que respecta a la intervención directa, la cual debe hacerse desde un enfoque pluridimensional, deben tomarse como referencia una serie de premisas:

- Conveniencia del tratamiento precoz. Progresivamente los órganos articulatorios van perdiendo plasticidad. Es más fácil corregir un rotacismo a los 6-7 años que a los 10 o 12, además la persistencia del problema articulatorio puede crear problemas de baja autoestima en el niño.
- Importancia de la colaboración de los padres.
- Partir de una buena evaluación (exploración).
- Elaborar un programa de trabajo.
- Explicarle al niño en que consiste el problema, lo que vamos a hacer así como el objetivo de cada ejercicio.
- Hacer una autoevaluación constante.
- Importancia de la empatía y refuerzo positivo.

Finalmente, en relación con la tipología de actividades, deben estar enfocadas a la articulación de aquellos sonidos que el sujeto no emita adecuadamente. Por ello, es importante tener en cuenta una serie de pasos encadenados en función (véase Figura 5), o de acuerdo, al diagnóstico y a los errores sintomatológicos que se encuentren en el sujeto (recuérdese que, por ejemplo, no toda apraxia o disartria tiene el mismo error), ya que dependiendo de los errores que se encuentren se trabajará más en una etapa que en otra.

Figura 5.

Modelo de intervención (Susanibar et al. 2016)



Este esquema de intervención se puede aplicar a cualquier TSH de acuerdo con el diagnóstico, principalmente, y está compuesto por cinco etapas. En una misma sesión pueden trabajarse errores fonéticos y fonológicos, dos o tres errores fonéticos al mismo tiempo o fonológicos al mismo tiempo, todo ello dependerá de una evaluación adecuada.

A nivel fonético se debe trabajar en base a la norma, sobre todo en la etapa de uno a dos años, primero se debe aprender la producción desde nivel fonético y acústico para poder saber en qué está errando el sujeto (Susanibar et al. 2014), y después se deben poner en marcha las denominadas pistas fonéticas, movimientos de las EAH realizados de manera activa, asistida o pasiva que son similares a los sonidos objetivo, pero que siempre están encaminadas a la emisión del sonido.

De este modo, se debe trabajar únicamente la habilidad motora necesaria para el sonido. Sin embargo, también debe tomarse en consideración que toda habilidad motora nueva debe tener una representación auditiva fonética-fonológica, sino no servirá.

A nivel fonológico, por su parte, sobre todo en la etapa de tres a cinco años, se deben trabajar únicamente las habilidades cognitivo-lingüísticas y, para ello, se debe conocer qué es la percepción fonológica (discriminación y reconocimiento), la organización léxico-gramatical (ya sea con el silabeo o no), los rasgos distintivos y/o rasgos fonéticos para compararlos perceptiva y productivamente , los pares mínimos para ayudar a reorganizar el sistema fonológico del niño y la comparación de significado.

Asimismo, también será importante que, aunque se trabajen únicamente las habilidades cognitivo-lingüísticas, toda palabra nueva que se aprenda debe tener una representación

léxico-semántica. Para todo lo anterior, pueden ponerse en marcha actividades de articulación del fonema asilado, de repetición de sílabas con el fonema, de repetición de palabras y de frases o en posición media.

3.2.3.7. Una última actualización en el Trastorno de los Sonidos del Habla: ¿por qué es un problema a tener en cuenta en el ámbito educativo?

El TSH no se ha librado de su cuota de abordajes ineficaces, de intervenciones que se han aplicado más por tradición que por un conocimiento sólido de su eficacia y de concepciones teóricas antiguas y algo atrasadas. Tradicionalmente, se habían dividido las dificultades que estos niños presentan en "fonéticas" (que tendrían que ver con problemas en la articulación del sonido) y "fonológicas" (que tendrían que ver con problemas para discriminar, manipular y representar mentalmente los sonidos del habla). Sin embargo, los autores especializados advierten de que una estricta dicotomía entre errores fonológicos y fonéticos "no parece muy prudente" (Farquharson et al., 2019).

Y es que la mayoría de los investigadores defienden que los procesos fonéticos y fonológicos están ampliamente entrelazados, emergen juntos en un sistema muy complejo como es el habla y requieren de una comprensión mucho más matizada. A lo anterior es necesario añadir que el TSH ha tardado en deshacerse de procedimientos de intervención poco fundamentados, relacionados con ejercicios musculares descontextualizados del habla o con actividades de soplo.

Al respecto Faquharson (2019) **también** realiza unas pequeñas recomendaciones para actualizar la evaluación y la intervención **que se suman a lo que hemos trabajado en apartados anteriores de esta unidad.**

Recomendaciones para la evaluación (Farquharson, 2019)

- Los profesionales deben examinar los errores del habla en conversaciones reales. Usar, únicamente, test de repetición de palabras aisladas pueden dar una idea errónea del tipo de errores y de la frecuencia con la que estos se producen.

- Es necesario incluir en la evaluaciones la repetición de palabras largas, para evaluar cómo la complejidad fonológica impacta en el deterioro del habla.

- Se debe considerar tanto la frecuencia como el tipo de errores (sustitución, omisión, asimilación…).

- Se debe evaluar el impacto que esta dificultad puede estar teniendo en la alfabetización o en la socialización.

Recomendaciones para la intervención (Farquharson, 2019)

- Sustituir las intervenciones articulatorias simples por aproximaciones más complejas basadas en lo que sabemos del aprendizaje fonético-fonológico (pares mínimos, oposiciones múltiples, oposiciones máximas…).

- No diferenciar las intervenciones de forma estricta entre fonéticas y fonológicas. Considerar la aplicación de intervenciones que aborden ambos aspectos.

- Trabajar de manera que se monitorice el progreso, se tomen decisiones basadas en datos y se ofrezca mayor exposición a aquellos que no responden.

- A lo anterior yo añadiría, a modo de apunte, las recomendaciones que de autores como Brosseau-Lapré con relación a incluir el trabajo en conciencia fonológica y la mejora en la percepción del habla si es necesario.

En definitiva, el TSH es un problema a tener en cuenta en el ámbito educativo. Puede provocar dificultades en la alfabetización, impacta en el desarrollo social del niño y en sus habilidades comunicativas. No parece sensato minimizarlo. Requiere un abordaje específico e individualizado que, de no recibirse, puede impactar de forma severa en los niños que lo presentan. Los profesionales deberían evitar partir de concepciones teóricas atrasadas y de prácticas ineficaces, que no parecen estar sustentadas en evidencias de calidad.

BIBLIOGRAFÍA

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5.ª ed., texto revisado). Washington, DC: APA.

Arbieto, K., Pablo, A., Núñez, D., y Narro, W. (2020). Estrategias de intervención logopédica en un caso de Trastorno del Desarrollo del Lenguaje. *Revista digital EOS Perú, 8*(2), 91-104.

Berthier, M. L., Casares, N. G., y Dávila, G. (2011). Afasias y trastornos del habla. *Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, 10*(74), 5035-5041.

Billard, C. (2014). Desarrollo y trastornos del lenguaje oral en la infancia. *EMC-Pediatría*, *49*(4), 1-11.

Bishop, D. V., Snowling, M. J., Thompson, P. A., y Greenhalgh, T. (2017). CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development. Phase 2. Terminology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *58*(10), 1068-1080

Bowen, C. (2015). *Children's Speech Sound Disorders*. Oxford: Wiley Blackwell.

Cepeda, A. (2019). Trastornos de la comunicación y lenguaje II: Intervención. EOPEP´S: Junta de Castilla y León. Disponible en: https://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/trastornos-comunicacion-lenguaje-ii-intervencion

Chávez, F. S. (2015). Trastorno de los sonidos del habla–TSH: Controversias y Evidencias en el Uso de Ejercicios Oromotores no Verbales en la Intervención. *Revista Científica Signos Fónicos, 1*(2), 47-49.

Coll-Florit, M., Vila-Rovira, J. M., Aguado, G., Fernández-Zúñiga, A., Gambra, S., y Perelló, E. (2014). *Trastornos del habla y de la voz.* Barcelona: UOC.

Farquharson, K. (2019). It might not be "just artic": The case for the single sound error. *Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, 4*(1), 76-84.

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 d emayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado,* núm. 340, de 30 de diciembre de 2020.

López, P. P., Soria, M. O., Luque, F. C., y Valero-García, A. V. (2016). Eficacia del entrenamiento en praxias fonoarticulatorias en los trastornos de los sonidos del habla en niños de 4 años. *Revista de logopedia, Foniatría y Audiología, 36*(2), 77-84.

Macías, E. M. M. (2010). ¿ Cuáles son las alteraciones del habla más frecuentes? *Pedagogía Magna, 17*(8), 100-107.

Marchesan, I. Q. (2015). Trastorno de los sonidos del habla–TSH: Cómo el diagnóstico basado en evidencia influye en la intervención. *Revista científica signos fónicos, 1*(2), 35-50.

Martínez-Sánchez, F. (2010). Trastornos del habla y la voz en la enfermedad de Parkinson. *Revista de Neurología, 51*(9), 542-550.

McCauley, R. J., y Fey, M. E.(2006). *Treatment of language disorders in children.* Paul H. Brookes Pub.

Mishquero, T., y Thalia, D. (2019). Desarrollo fonológico en niños de 6 años a 6 años 11 meses, en la Academia Militar del Valle del sector Conocoto en el período mayo–agosto 2017. Tesis Doctoral. Universidad de Quito: UCE.

Namasivayam, A. K., Coleman, D., O'Dwyer, A. yVan Lieshout, P. (2020). Speech sound disorders in children: An articulatory phonology perspective. *Frontiers in psychology, 10,* 2998.

Rojas, A. R., y Susanibar, F. (2019). Alcances teóricos y metodológicos en torno a la conciencia fonológica. *Revista digital EOS Perú, 7*(2), 107-135.

Susanibar F., Dioses A., y Castillo J. (2014). Evaluación de Motricidad Orofacial. En: Susanibar F, Marchesan I, Parra D, Dioses A. (Coord.). *Tratado de evaluación de Motricidad Orofacial*. Madrid: EOS.

Susanibar, F., Dioses, A., Marchesan, I., Guzmán, M., Leal, G., Guitar, B., y Junqueira, A. (2016). *Trastornos del habla: de los fundamentos a la evaluación*. Madrid: Giunti EOS.

Susanibar, F., y Valdés, C. (2019). Evaluación e Intervención logopédica en motricidad orofacial y áreas afines. Madrid: Giunti EOS.

Toledo, N., y De Ávila, C. (2021). Trastornos persistentes de los sonidos del habla en niños con y sin alteraciones del lenguaje: características fonológicas y desempeño motor oral. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 41*(2), 82-92.

Vergara, V., Ospina, J. C., y Muñoz, N. C. (2020). Consideraciones sobre la relación entre la variación dialectal y el abordaje terapéutico de los trastornos del habla. International *Journal of Medical and Surgical Sciences, 7*(3), 1-5.